

ד"ר אילן תירוש - פסיכיאטר מומחה

מספר רישיון: 11-88888

סיכום אבחנתי והערכה קלינית

פגשתי את הפצינט בתאריך 24/05/2026

מעקב תקופתי והתאמת תוכנית טיפול

- דיווח מטופל: חל שיפור משמעותי ודרמטי ברמות החיוניות והאנרגיה במהלך היום מאז העברת התרופה לשעות הערב; תופעת הלוואי של הטשטוש בבוקר חלפה כמעט כליל. המטופל ישן כעת כ-5.5 שעות בריצפות ברוב הלילות. יחד עם זאת, המטופל מתאר אירוע חריף של פלאשבק והצפה רגשית קשה שחווה במקום עבודתו בעקבות טריגר של רעש עוצמתי, ומציין חרדה תמידית מפני הישנות של התקפים דומים שבהם הוא מרגיש חוסר אונים מוחלט וחוסר יכולת לפעול.
- סטטוס פסיכיאטרי: אפקט מאוזן יותר, קוהרנטי, מדווח על תפקוד משופר בעבודה. אוריאנטציה מלאה. אין עדות לסיכון או למחשבות טורדניות מג'וריות.
- התרשמות רפואית: הטיפול בציפרלקס יציב ומשיג את מטרתו ארוכת הטווח, נשארים על מינון של 10 מ"ג בערב. עם זאת, ישנו צורך רפואי במתן מענה תרופתי ממוקד ומהיר להתקפי פאניקה חריפים בזמן אמת, (**Acute distress**) לשימוש נקודתי בלבד, מבלי לייצר תלות.

המלצות:

1. המשך קו טיפול קבוע: המשך נטילת כדור ציפרלקס (10 מ"ג) מדי ערב בשעה 20:00.
2. תוספת טיפול תרופתי לחירום: (**SOS**) שילוב כדור קלונקס (**Clonex**) במינון של 0.5 מ"ג – לחירום בלבד. המטופל ייטול חצי כדור או כדור שלם רק במצב של התקף חרדה חריף, פאניקה קיצונית או הצפה קוגניטיבית שאינה מגיבה לתרגול הקרקוע הפיזי. אין ליטול תרופה זו באופן קבוע או יומיומי. מוגבל למקסימום 3 פעמים בשבוע.